

TEMA 6.7 • INFECTOLOGÍA

Fiebre sin Foco y Fiebre de Origen Desconocido

PERFIL EUNACOM 1.05.1.007
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Fiebre sin Foco y Fiebre de Origen Desconocido (FOD)

Definiciones

TABLA 6.7.1: ENTIDAD VS DEFINICIÓN	
ENTIDAD	DEFINICIÓN
Fiebre	T° ≥ 38°C (consenso pediátrico) / ≥ 37°C-37.5°C (adultos, sin consenso claro)
Fiebre con foco	Existe un síntoma o signo que orienta al foco infeccioso (faringitis, disuria, etc.)
Fiebre sin foco (FSF)	No hay síntomas ni signos que orienten a un foco
FOD	Fiebre ≥ 38°C durante > 2 semanas + estudio básico sin diagnóstico

Causas de FOD

TABLA 6.7.2: CATEGORÍA VS EJEMPLOS CLAVE		
CATEGORÍA	EJEMPLOS CLAVE	
Infecciosa (más frecuente)	CMV, VEB, VIH, TBC, Bartonella henselae, Brucella, Toxoplasma, Malaria	
Autoinmune	Lupus, Artritis Reumatoide: Clínica y Diagnóstico	Artritis Reumatoide, Arteritis de la temporal (adultos mayores), Artritis Idiopática Juvenil / Enfermedad de Still
Neoplásica	Linfomas y leucemias (hematológicos), Hipernefroma, Hepatocarcinoma	
Farmacológica	Fiebre por fármacos (misoprostol, anticonvulsivantes, etc.)	

Estudio Escalonado de la FOD

Paso 0: Anamnesis + Examen físico completo + Rx Tórax + Hemograma + Hemocultivos + Orina.

Paso 1: Estudio inmunológico (ANA, FR, ANCA) + Serología para agentes frecuentes (IgM VEB, CMV, Bartonella, Toxoplasma, VIH, TBC).

- Paso 2 — Imágenes:
- Ecocardiograma → Descartar endocarditis.
- TAC Tórax-Abdomen-Pelvis → Buscar abscesos, adenopatías, masas neoplásicas.
- Cintigrafía ósea → Si se sospecha osteomielitis u osteólisis tumoral.

Paso 3 — Biopsia de médula ósea → Buscar leucemia, linfoma, mieloma, TBC diseminada.

Paso 4: Ampliar búsqueda a infecciones raras (Tularemia, Brucelosis, Rickettsia, etc.) según exposiciones y viajes.

EUNACOM CRITERIOS
Si la fiebre desaparece espontáneamente → probablemente era viral. Es válido documentar sin diagnóstico definitivo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Paciente de 45 años con fiebre >38°C de 3 semanas y estudio básico negativo. ¿Cuál es el siguiente paso en el estudio?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Fiebre sin Foco y Fiebre de Origen Desconocido. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

- PUNTOS CLAVE DESTACADOS
- FOD: fiebre >38°C + >2 semanas + estudio negativo. Causas más frecuentes: infecciosas.
 - Arteritis temporal: causa frecuente de FOD en adultos mayores. AIJ/Still en niños.
 - Cáncer como causa de FOD: hematológicos, hipernefroma, hepatocarcinoma.
 - Estudio escalonado: generales → serología → imágenes (eco, TAC) → biopsia medular → raras.
 - Bartonella henselae: causa importante de fiebre sin foco en pediatría.
 - Si la fiebre desaparece espontáneamente, lo más probable es que era viral.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (FIEBRE SIN FOCO Y FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO)

PREGUNTA 1

Paciente de 45 años con fiebre $>38^{\circ}\text{C}$ de 3 semanas y estudio básico negativo. ¿Cuál es el siguiente paso en el estudio?

- A) Repetir hemocultivos y examen de orina
- B) Solicitar ANA, FR, IgM para CMV, VEB y Bartonella
- C) Biopsia de médula ósea
- D) TAC de tórax, abdomen y pelvis
- E) Tratamiento empírico con antibióticos de amplio espectro

PREGUNTA 2

Niño de 6 años con fiebre de 3 semanas, adenopatías cervicales y antecedente de arañazo de gato. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Mononucleosis infecciosa
- B) Enfermedad por arañazo de gato (Bartonella henselae)
- C) Linfoma de Hodgkin
- D) Tuberculosis ganglionar
- E) Toxoplasmosis

PREGUNTA 3

Adulto mayor de 75 años con FOD de 4 semanas. Refiere cefalea temporal y claudicación mandibular. VHS muy elevada. ¿Cuál es la causa más probable?

- A) Tuberculosis
- B) Arteritis temporal
- C) Leucemia
- D) Endocarditis infecciosa
- E) Lupus eritematoso sistémico

RESUMEN: FIEBRE SIN FOCO Y FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO

Esta clase diferencia la fiebre sin foco (FSF) de la fiebre de origen desconocido (FOD). Fiebre se define como temperatura $>37^{\circ}\text{C}$ (en pediatría $>38^{\circ}\text{C}$). La FSF es cuando no hay foco infeccioso evidente. La FOD requiere: fiebre $>38^{\circ}\text{C}$, >2 semanas de duración, y estudio negativo. Las causas de FOD son: infecciosas (las más frecuentes: CMV, VEB, VIH, TBC, Bartonella, brucela, malaria), autoinmunes (lupus, artritis reumatoide, arteritis temporal en adultos mayores, artritis reumatoide juvenil/enfermedad de Still en niños), cáncer (hematológicos, hipernefroma, hepatocarcinoma) y fármacos. El estudio se escalona: nivel 0 (anamnesis, examen físico, exámenes generales), nivel 1 (serología infecciosa y autoinmune), nivel 2 (ecocardiograma, TAC, cintigrafía), nivel 3 (biopsia medular), nivel 4 (infecciones y enfermedades raras). Si desaparece la fiebre, probablemente era viral.